UE B1.3 S1 · 27 OCTOBRE 2026

FIÈVRE AU RETOUR DE VOYAGE ET PALUDISME

Fiche de révision écrite

FIL CONDUCTEUR

Déterminer d'abord si le tableau impose une action urgente, puis relier les symptômes à la géographie, à la chronologie et aux expositions. Face à une exposition palustre, ne jamais laisser un tableau banal retarder la recherche du parasite.

Objectifs de révision tirés du cours

- Interroger un voyageur fébrile de façon structurée et distinguer causes cosmopolites et tropicales.
- Connaître le cycle de *Plasmodium*, le rôle de l'anophèle et les mécanismes de gravité de *P. falciparum*.
- Identifier les examens diagnostiques, les formes simples/graves, les principes de traitement et la prévention.
- Relier ces notions aux tâches et vigilances de l'équipe infirmière.

Mode de lecture

ESSENTIEL	POUR COMPRENDRE	EN SITUATION
Les notions à mémoriser.	Le mécanisme et ses nuances.	L'application au raisonnement de soin.

Sommaire

Pourquoi une fièvre au retour de voyage demande un raisonnement spécifique 3

Deux familles d'étiologies : différencier sans opposer 3

Interrogatoire du voyageur : les données qui changent la décision 4

Incubation : utiliser la chronologie avec prudence 5

Examen clinique et examens initiaux : démarche systématique 5

Voyage, soins à l'étranger et bactéries multirésistantes 6

Paludisme : agent, transmission et enjeux 7

Cycle de Plasmodium : du moustique aux globules rouges 7

Pourquoi P. falciparum peut devenir grave : cytoadhérence et séquestration 8

Clinique : accès simple et accès grave 8

Diagnostic parasitologique : examens à connaître 9

Traitements : ne pas confondre paludisme simple et grave 10

Surveillance infirmière et suivi après traitement 11

Prévention du paludisme avant le départ 11

Confusions fréquentes — à réviser 12

L'essentiel du cours en résumé 13

Lexique et terminologie 13

Pourquoi une fièvre au retour de voyage demande un raisonnement spécifique

À RETENIR

L'enjeu n'est pas de chercher uniquement une maladie « exotique » : il faut envisager les infections courantes, identifier les expositions du voyage et surtout ne pas manquer le paludisme.

POUR COMPRENDRE

Un voyageur peut revenir avec une infection rencontrée partout dans le monde : **grippe, infection respiratoire, infection urinaire, gastroentérite** ou infection virale. Ces maladies dites **cosmopolites** restent fréquentes, même après un séjour tropical.

Parallèlement, certaines infections dépendent d'une exposition géographique ou environnementale particulière : **paludisme, arboviroses (dengue, chikungunya), fièvre typhoïde, leptospirose, hépatites**, entre autres. La probabilité varie selon le pays, la saison, le type d'activités et les conditions du séjour.

L'intervenant insiste : **le paludisme est une priorité diagnostique** chez un patient ayant séjourné dans une zone où la transmission existe. Son tableau peut être trompeur et sa forme grave évoluer rapidement.

NOTE DE COURS

Le cours oppose explicitement « causes cosmopolites » et « causes tropicales ». Certaines séries de consultations rapportent des fièvres restant sans étiologie identifiée malgré les explorations ; ce chiffre est un ordre de grandeur d'études, pas un diagnostic par défaut.

EN SITUATION DE SOIN

Un patient revient d'une région tropicale avec fièvre et rhinorrhée. Une grippe est plausible, mais elle ne dispense pas de rechercher un paludisme si le séjour comportait une exposition à risque.

Deux familles d'étiologies : différencier sans opposer

À RETENIR

L'anamnèse et l'examen clinique servent à hiérarchiser les hypothèses, pas à choisir artificiellement entre « maladie commune » et « maladie tropicale ».

POUR COMPRENDRE

Une même manifestation peut appartenir à plusieurs familles : **ictère fébrile** (paludisme, hépatite, leptospirose…), **syndrome digestif**, **manifestations neurologiques** ou **éruption cutanée**. Le tableau clinique doit être interprété avec le pays d'exposition.

Les **arboviroses** sont à évoquer devant un contexte compatible, souvent associé à des douleurs et parfois à un exanthème. L'absence d'éruption n'exclut cependant aucune étiologie à elle seule.

Cause cosmopolite	Cause tropicale ou liée au voyage
Grippe, rhinovirus, autres viroses respiratoires	Paludisme dans une zone de transmission

Cause cosmopolite	Cause tropicale ou liée au voyage
Infection urinaire, pneumonie	Dengue, chikungunya, autres arboviroses selon zone
Infections digestives fréquentes	Fièvre typhoïde, leptospirose, certaines parasitoses selon contexte

NOTE DE COURS

Le cours explique que le paludisme se retrouve dans de nombreux tableaux : digestif, ictérique, neurologique ou syndrome fébrile peu caractéristique. Un signe focal peut orienter, mais il ne remplace pas l'évaluation du risque palustre.

Interrogatoire du voyageur : les données qui changent la décision

À RETENIR

Toujours dater, localiser et caractériser l'exposition : « où, quand, combien de temps, comment ? »

POUR COMPRENDRE

Recueillir **pays et régions visités, dates de départ et de retour, dates de début des symptômes**, puis les escales ou séjours successifs. Les dates encadrent la période d'exposition et aident à rapprocher le tableau des incubations possibles.

Interroger les comportements : **piqûres de moustiques, baignade en eau douce, marche pieds nus, consommations d'eau et d'aliments, contact animal, rapports sexuels non protégés, séjour en structure de soins**. Des activités très différentes, dans un même pays, ne donnent pas les mêmes expositions.

Préciser le **terrain** : âge, grossesse, immunodépression, maladie chronique, antécédents, traitements et tolérance clinique. Relever les vaccinations et la chimioprophylaxie antipaludique, avec le nom de la molécule, l'observance et les dates de prise.

Donnée à recueillir	Pourquoi elle compte
Pays, zones, dates	Associer le risque géographique à une période d'exposition
Activités, eau, alimentation, piqûres	Orienter vers les voies de transmission plausibles
Vaccins et prévention antipaludique	Apprécier un risque résiduel, sans conclure à une exclusion
Antécédents, immunité, grossesse	Repérer les terrains vulnérables et les présentations modifiées

NOTE DE COURS

Formule récurrente de l'enseignant : « Dis-moi comment tu as vécu [ton voyage] et je te dirai ce que tu as comme maladie. » Il s'agit d'une méthode d'enquête clinique, pas d'une certitude à partir du comportement.

EN SITUATION DE SOIN

Deux voyageurs reviennent du même pays : l'un a effectué des excursions avec baignades et nuits en extérieur, l'autre un séjour urbain. Les hypothèses ne seront pas hiérarchisées de la même façon.

Incubation : utiliser la chronologie avec prudence

À RETENIR

Les périodes d'incubation se chevauchent. Un délai n'est qu'un argument d'orientation : il ne suffit pas pour exclure un diagnostic.

POUR COMPRENDRE

L'enseignant regroupe les présentations en **délais courts (moins de 7 jours)**, **intermédiaires (7 à 14 jours)** et **plus prolongés (au-delà de 14 jours)**. Cette classification donne un ordre de raisonnement, sans limites biologiques rigides.

Le paludisme peut apparaître dans plusieurs fenêtres ; la possibilité de manifestations tardives dépend notamment de l'espèce de *Plasmodium* et des circonstances, y compris une chimioprophylaxie imparfaitement suivie.

Repère de délai (cours)	Exemples proposés en séance
Moins de 7 jours	Diarrhée du voyageur ; certaines arboviroses ; rickettsioses
7 à 14 jours	Paludisme ; fièvre typhoïde ; certaines infections bactériennes et parasitaires
Plus de 14 jours	Paludisme possible ; hépatites ; amibiase ; autres causes selon exposition

NOTE DE COURS

La chronologie doit considérer la date du premier et du dernier risque d'exposition, pas seulement le jour du retour. Pour *P. vivax* et *P. ovale*, les formes hépatiques dormantes expliquent la possibilité de rechutes très tardives.

Examen clinique et examens initiaux : démarche systématique

À RETENIR

Distinguer une fièvre avec foyer évident d'une fièvre « nue », tout en conservant la priorité de l'évaluation du paludisme après exposition pertinente.

POUR COMPRENDRE

L'évaluation repose sur les **constantes et la gravité immédiate**, l'examen des appareils respiratoire, urinaire, digestif, cutané, neurologique et cardio-circulatoire, ainsi que la recherche d'un ictère, de douleurs, d'une éruption ou d'adénopathies.

Une **fièvre focale** a un point d'appel (par exemple toux et signes respiratoires, brûlures urinaires ou douleur lombaire). Une **fièvre nue** n'a pas de focalisation évidente ; elle appelle une démarche structurée plutôt qu'une batterie indifférenciée de tests.

Selon les signes et prescriptions : examens biologiques de première intention, **hémocultures** lorsqu'elles sont indiquées, bilan urinaire et autres examens ciblés. Si le risque de paludisme existe, **un prélèvement destiné au diagnostic palustre est urgent**.

Situation	Raisonnement infirmier
Troubles de vigilance, détresse, choc	Alerter immédiatement et participer à la prise en charge urgente
Retour d'une zone de transmission + symptômes compatibles	Signaler le risque palustre sans attendre un pic thermique
Point d'appel localisé	Décrire précisément les signes, préparer les examens ciblés prescrits
Hémocultures prescrites	Respecter l'asepsie, les modalités et volumes de remplissage selon protocole

NOTE DE COURS

Insistance orale explicite : **des hémocultures correctement remplies** sont essentielles à leur rendement diagnostique. La qualité pré-analytique fait partie du rôle infirmier.

EN SITUATION DE SOIN

Un patient présente des céphalées, une gêne abdominale et une température normale au triage ; il indique avoir eu des frissons après un voyage en zone palustre. L'absence de fièvre mesurée à cet instant ne rassure pas.

Voyage, soins à l'étranger et bactéries multirésistantes

À RETENIR

Le voyage et surtout l'hospitalisation ou les soins à l'étranger doivent être signalés lors de l'évaluation du risque de portage de bactéries résistantes.

POUR COMPRENDRE

L'enseignant rappelle le risque de **portage ou d'infection par des bactéries multirésistantes (BMR)** après certaines expositions, notamment aux établissements de soins et aux procédures médicales réalisées à l'étranger.

Le soignant recherche les antécédents d'hospitalisation, de transfert sanitaire ou d'actes invasifs, prévient l'équipe et applique les **protocoles locaux de dépistage et de précautions complémentaires** lorsqu'ils sont indiqués. Ne pas déduire automatiquement une indication universelle d'isolement du seul fait d'avoir voyagé.

Le paludisme n'est pas transmis directement d'un patient à l'autre par les contacts ordinaires. Il ne justifie pas, à lui seul, un isolement contact ; d'autres risques associés au retour de voyage peuvent en revanche motiver des précautions distinctes.

NOTE DE COURS

Le cours emploie parfois des formulations très générales au sujet de l'isolement des voyageurs : l'application pratique doit toujours être rapprochée de la procédure d'hygiène et du contexte patient.

Paludisme : agent, transmission et enjeux

À RETENIR

Le paludisme est une parasitose due à un protozoaire du genre *Plasmodium*, transmis habituellement par la piqûre d'une femelle *Anopheles* infectée.

POUR COMPRENDRE

Le cours met l'accent sur **Plasmodium falciparum**, associé aux formes graves et à la séquestration des globules rouges dans les microvaisseaux. D'autres espèces sont citées, notamment *P. vivax*, *P. ovale*, *P. malariae* et *P. knowlesi*.

Le paludisme demeure un **problème majeur de santé publique mondiale**, avec une charge particulièrement importante en Afrique subsaharienne et chez les jeunes enfants. En France, les cas diagnostiqués sont très majoritairement liés à une infection acquise à l'étranger.

L'intervenant présente la découverte de l'agent parasitaire par **Alphonse Laveran en 1880**. Cette histoire rappelle le rôle fondamental de l'examen sanguin dans le diagnostic.

NOTE DE COURS

Les chiffres annuels montrés dans les diapositives (cas, décès, tendances, létalité) dépendent de la date et de la source statistique. Le point durable à retenir est la charge mondiale, le risque de formes graves et le caractère urgent du diagnostic.

Cycle de Plasmodium : du moustique aux globules rouges

À RETENIR

Comprendre les deux grandes phases chez l'être humain — hépatique puis érythrocytaire — et le retour au moustique par les formes sexuées.

POUR COMPRENDRE

1. La **femelle anophèle** inocule des **sporozoïtes** lors d'une piqûre. Ceux-ci gagnent rapidement le foie et infectent les **hépatocytes**.

2. Au terme de la **phase hépatique**, les formes parasitaires libèrent des **mérozoïtes** qui pénètrent dans les **érythrocytes** (globules rouges).

3. La **phase érythrocytaire** comporte des stades de maturation et de multiplication (anneau, trophozoïte, schizonte) puis une rupture des globules rouges avec libération de nouveaux mérozoïtes. Le cycle de *P. falciparum* est présenté en séance sur un rythme d'environ **48 heures**.

4. Certaines formes deviennent des **gamétocytes**, ingérés par un autre moustique au cours d'un repas sanguin. Le **cycle sexué** a lieu chez ce moustique, qui pourra ensuite transmettre le parasite.

Chez *P. vivax* et *P. ovale*, des formes dormantes dans le foie peuvent être à l'origine de rechutes longtemps après l'exposition initiale. Ce mécanisme ne doit pas être confondu avec une nouvelle piqûre.

Phase	Lieu	Repères
Inoculation	Piqûre d'anophèle femelle	Sporozoïtes

Phase	Lieu	Repères
Multiplication initiale	Foie / hépatocytes	Phase hépatique, souvent silencieuse
Multiplication sanguine	Globules rouges	Mérozoïtes, stades annulaires, trophozoïtes, schizontes
Transmission au vecteur	Sang humain puis moustique	Gamétocytes ; cycle sexué chez le moustique

NOTE DE COURS

Le professeur explique plusieurs fois l'enchaînement foie → globules rouges → moustique. Le **moustique est l'hôte définitif** au sens parasitologique, car la reproduction sexuée s'y déroule.

Pourquoi P. falciparum peut devenir grave : cytoadhérence et séquestration

À RETENIR

La gravité n'est pas seulement une question de fièvre : les hématies parasitées peuvent adhérer aux microvaisseaux et perturber la perfusion des organes.

POUR COMPRENDRE

À mesure que le parasite mûrit dans le globule rouge, des **protéines parasitaires** apparaissent à la surface de la cellule infectée. Certaines favorisent son adhésion à la paroi vasculaire : c'est la **cytoadhérence**.

Le cours décrit également le **rosetting** (association d'une hématie parasitée avec des hématies non parasitées) et d'autres phénomènes d'agrégation. Ensemble, ils participent à la **séquestration microvasculaire**.

La microcirculation d'organes comme le **cerveau, les poumons et les reins** peut être altérée. Cela contribue aux défaillances d'organes du paludisme grave, parfois rapidement et sans signes spécifiques au début.

NOTE DE COURS

Distinction fondamentale répétée à l'oral : **cycle parasitaire** (multiplication du parasite) et **physiopathologie** (conséquences sur la microcirculation et les organes) ne sont pas synonymes.

EN SITUATION DE SOIN

Une céphalée banale peut précéder une aggravation neurologique. C'est précisément pourquoi une suspicion crédible de paludisme exige une orientation immédiate.

Clinique : accès simple et accès grave

À RETENIR

Le paludisme peut être très peu spécifique. La fièvre est fréquente mais peut manquer au moment de l'examen ; la gravité se juge aussi sur les défaillances cliniques et biologiques.

POUR COMPRENDRE

La **primo-invasion** peut associer céphalées, myalgies, asthénie, malaise, douleurs abdominales, nausées, vomissements et parfois diarrhée. Le tableau peut évoquer une simple virose ou une gastroentérite.

L'**accès palustre rythmé** classique associe frissons, chaleur/fièvre, puis sueurs. La périodicité est un repère historique, mais **ne doit jamais être attendue** pour soupçonner ou diagnostiquer la maladie.

Une température normale lors d'un passage aux urgences ne suffit pas à exclure le diagnostic. Les formes graves peuvent présenter un ou plusieurs signes de défaillance d'organe.

Signes ou critères cités en cours	Conduite à comprendre
Troubles de conscience, convulsions, coma	Risque neurologique majeur : urgence
Détresse respiratoire, défaillance circulatoire	Risque vital et prise en charge adaptée
Hypoglycémie, acidose / lactates élevés	Signes biologiques de gravité possibles
Anémie importante, atteinte rénale, ictère, charge parasitaire élevée	Évaluer l'ensemble du patient et les critères retenus par l'équipe

NOTE DE COURS

La classification « simple / grave » guide le **traitement** et le lieu de surveillance. Un seul critère de gravité confirmé peut modifier le parcours de soins selon les recommandations utilisées.

EN SITUATION DE SOIN

Au retour d'une zone palustre, des vomissements et des céphalées ne doivent pas être attribués mécaniquement à une intoxication alimentaire si l'état général est altéré.

Diagnostic parasitologique : examens à connaître

À RETENIR

Le diagnostic est recherché en urgence à partir du sang : frottis, goutte épaisse, tests rapides et, selon les laboratoires, méthodes moléculaires.

POUR COMPRENDRE

Le **frottis sanguin** étale le sang sur une lame ; après préparation et coloration, l'observation au microscope peut mettre en évidence les formes intra-érythrocytaires, aider à identifier l'espèce et à estimer la parasitémie.

La **goutte épaisse** est une préparation concentrant la recherche parasitaire. Les **tests de diagnostic rapide (TDR)** peuvent rechercher des antigènes, par exemple HRP2 ; ils sont utiles selon le contexte mais ne doivent pas être présentés comme un remplacement universel de la microscopie.

Les méthodes d'**amplification des acides nucléiques** (dont PCR et LAMP, techniques différentes) peuvent présenter une très grande sensibilité selon les procédés. Le choix et la répétition éventuelle des tests relèvent du protocole médical et biologique.

Examen	Ce qu'il apporte	Point de vigilance
Frottis sanguin	Visualisation des parasites, espèce / parasitémie	Qualité de prélèvement et expertise de lecture
Goutte épaisse	Recherche parasitaire sensible par concentration	Nécessite préparation/lecture adaptées
TDR antigénique	Réponse rapide utile selon contexte	Performances et cibles variables
PCR / LAMP	Détection moléculaire sensible	Dépend du laboratoire ; ne pas retarder la prise en charge

NOTE DE COURS

Le cours insiste sur l'identification des parasites **dans les globules rouges** et sur le caractère urgent du prélèvement. Les performances chiffrées mentionnées sont spécifiques aux techniques et ne doivent pas devenir des seuils universels.

Traitements : ne pas confondre paludisme simple et grave

À RETENIR

Le traitement d'un accès simple et celui d'un accès grave n'empruntent pas la même voie initiale ; le relais oral complet après artésunate IV est un point majeur du cours.

POUR COMPRENDRE

Pour l'**accès non compliqué à P. falciparum**, le professeur présente des **associations antipaludiques orales**, notamment arténimol-pipéraquine et artéméther-luméfantrine. Les modalités de prise et les contre-indications dépendent du produit prescrit.

Pour l'**accès palustre grave**, l'exposé retient l'**artésunate intraveineux**, associé à une prise en charge des défaillances d'organes. Dès que la situation permet le relais, un **traitement oral complet** doit terminer la cure conformément à la prescription.

Les conditions d'administration ne sont pas interchangeables : l'intervenant cite une prise à jeun pour **arténimol-pipéraquine**, alors que d'autres associations demandent une prise avec de la nourriture. Le nom exact du médicament et sa notice/protocole doivent être vérifiés avant administration.

Accès palustre simple	Accès palustre grave
Traitement généralement oral, selon prescription et évaluation	Artésunate IV et prise en charge urgente des défaillances
Assurer l'administration complète et la tolérance	Surveillance rapprochée, puis relais oral complet
Vérifier horaires, alimentation, interactions et effets indésirables	Coordonner perfusions, surveillance clinique et examens biologiques

NOTE DE COURS

Point fortement répété par l'enseignant : le relais oral après artésunate IV est obligatoire dans le schéma présenté. Il ne faut pas interpréter l'amélioration clinique comme l'arrêt anticipé de la cure.

EN SITUATION DE SOIN

Un patient traité par artésunate IV va mieux après quelques doses. L'équipe prépare le relais oral prévu ; l'amélioration ne signe pas que le traitement est terminé.

Surveillance infirmière et suivi après traitement

À RETENIR

Surveiller simultanément l'évolution clinique, la tolérance des antipaludiques et le risque de complications ou de réapparition de signes.

POUR COMPRENDRE

Au cours de l'hospitalisation, surveiller selon le contexte et les prescriptions : **état de conscience, température, respiration, circulation, diurèse, glycémie, hydratation, tolérance digestive** et examens biologiques pertinents.

Après une forme grave, le professeur décrit un suivi durant les semaines qui suivent, portant sur la **recrudescence parasitaire** et sur une possible **anémie hémolytique retardée après artésunate IV**. Il cite une vigilance particulière autour des contrôles de la deuxième et de la troisième semaine.

L'infirmier ou l'infirmière contribue à vérifier la bonne compréhension du traitement oral de relais, les rendez-vous et les signes justifiant une nouvelle consultation.

NOTE DE COURS

Le suivi présenté sur les diapositives comporte plusieurs points de contrôle jusqu'à environ **J28**. Les dates précises sont à appliquer selon les prescriptions et protocoles actualisés ; le principe est de **ne pas perdre le patient de vue** après sa sortie.

Prévention du paludisme avant le départ

À RETENIR

Deux leviers complémentaires : limiter les piqûres de moustiques et évaluer l'indication d'une chimioprophylaxie adaptée au voyage.

POUR COMPRENDRE

La **prévention des piqûres** comprend notamment la **moustiquaire imprégnée**, mentionnée avec insistance dans le cours, et les autres mesures anti-vectorielles adaptées.

La **chimioprophylaxie** est choisie selon le **pays et la zone précise, les modalités du séjour, le terrain et les contre-indications**. L'intervenant cite notamment l'atovaquone-proguanil et la doxycycline. Les calendriers de début et surtout de poursuite après le retour **diffèrent selon la molécule** : ne pas généraliser une seule durée à tous les médicaments.

Aucune stratégie n'assure une protection absolue : des symptômes compatibles après un séjour à risque imposent une consultation et la mention explicite du voyage, même si une prévention a été suivie.

Mesure	Rôle
Réduction des piqûres	Diminuer l'exposition au vecteur
Moustiquaire imprégnée	Protection pendant le sommeil selon conditions
Chimioprophylaxie prescrite	Réduire le risque, sans l'annuler
Information après le retour	Faire rechercher le paludisme en cas de symptômes

NOTE DE COURS

La présentation oppose schématiquement le risque en Afrique subsaharienne à d'autres régions ; pour un patient réel, **ne pas conclure « prophylaxie inutile » pour toute l'Asie ou toute l'Amérique** sans évaluation individualisée.

Pièges QCM / confusions à éviter

MÉTHODE

Lire chaque proposition en vérifiant sa portée : une phrase peut être vraie dans un cas et fausse si elle se présente comme une règle universelle.

01. Une cause cosmopolite n'exclut pas une cause tropicale — Une grippe ou infection urinaire plausible ne suffit pas à faire oublier l'exposition palustre.

02. Température normale au triage ≠ paludisme exclu — Fièvre intermittente, frissons et tableau digestif peuvent masquer l'accès.

03. Fièvre tierce rythmée ≠ présentation obligatoire — Ne pas attendre des pics tous les deux jours pour rechercher le parasite.

04. Frottis, goutte épaisse, TDR et PCR/LAMP ≠ synonymes — Techniques et fonctions diffèrent ; le laboratoire choisit l'algorithme.

05. Moustique vecteur ≠ transmission par contact ordinaire — Le paludisme ne relève pas, à lui seul, d'un isolement contact.

06. Cycle hépatique ≠ cycle érythrocytaire — Le premier précède l'invasion sanguine ; le second explique les accès cliniques.

07. Gamétocytes ≠ sporozoïtes — Les premiers sont ingérés par le moustique ; les seconds sont inoculés à l'humain.

08. Accès simple ≠ accès grave — La présence d'un critère de gravité change la stratégie thérapeutique.

09. Artésunate IV ≠ cure complète seule — Le relais oral complet est répété comme indispensable dans le cours.

10. Tous les antipaludiques n'ont pas les mêmes consignes alimentaires — Il faut vérifier la spécialité exacte et la prescription.

11. Prévention prise ≠ paludisme impossible — L'observance et l'efficacité ne sont pas absolues ; la maladie reste possible.

12. Prophylaxie après retour ≠ durée unique — Le calendrier dépend de la molécule ; ne pas recopier une durée de 7 jours pour la doxycycline.

Synthèse générale — L'essentiel du cours

> **LE FIL ROUGE**
> Retour de voyage + signes compatibles + exposition à risque : rechercher en urgence un paludisme tout en évaluant les autres causes possibles.

• Au retour de voyage, **poser les bonnes questions** : destination, dates, activités, protections et terrain.

• Hiérarchiser causes **cosmopolites** et causes **tropicales** en fonction des signes et de l'exposition.

• En cas de séjour en zone de transmission, le **paludisme doit être évalué rapidement** même si la température mesurée est normale.

• *Plasmodium* est transmis par une **anophèle femelle** ; phase hépatique puis sanguine ; formes sexuées reprises par le moustique.

• **P. falciparum** peut provoquer cytoadhérence, séquestration et défaillances d'organes.

• Le diagnostic repose sur les examens sanguins appropriés ; **simple** et **grave** sont deux cadres de traitement distincts.

• Un paludisme grave relève d'**artésunate IV** puis d'un **relais oral complet** ; suivre l'évolution et l'anémie tardive.

• Prévenir par **protection anti-vectorielle** et chimioprophylaxie individualisée ; rappeler le voyage si des symptômes apparaissent.

Définitions et mots-clés

Lexique organisé pour la mémorisation et la lecture vocale.

Anamnèse — Recueil structuré de l'histoire et des expositions d'un patient.

Arbovirose — Infection virale transmise par un arthropode vecteur, notamment certains moustiques.

Anophèle — Moustique dont certaines femelles peuvent transmettre les parasites du paludisme.

Antipaludique — Médicament utilisé dans la prévention ou le traitement du paludisme.

Artésunate — Dérivé de l'artémisinine utilisé notamment par voie intraveineuse dans le paludisme grave.

Artéméther-luméfantrine — Association antipaludique orale citée pour l'accès simple.

Arténimol-pipéraquine — Association antipaludique orale avec consignes spécifiques d'administration.

BMR — Bactérie multirésistante à plusieurs familles d'antibiotiques.

Chimioprophylaxie — Administration de médicaments pour réduire le risque de maladie.

Cytoadhérence — Adhésion de globules rouges parasités à la paroi des microvaisseaux.

Dengue — Arbovirose pouvant provoquer une maladie fébrile après exposition au vecteur.

Délai d'incubation — Temps entre l'exposition infectante et l'apparition des symptômes.

Érythrocyte — Globule rouge, cellule sanguine qui transporte l'oxygène.

Exanthème — Éruption cutanée diffuse accompagnant certaines maladies.

Fièvre focale — Fièvre associée à un point d'appel clinique localisé.

Fièvre nue — Fièvre sans foyer évident identifié à l'examen initial.

Frottis sanguin — Sang étalé sur lame et examiné après préparation et coloration.

Gamétocyte — Forme sexuée de Plasmodium circulant dans le sang et ingérée par le moustique.

Goutte épaisse — Préparation sanguine concentrée pour rechercher des parasites.

Hépatocyte — Cellule du foie susceptible d'être infectée au début du cycle palustre.

Hémoculture — Prélèvement de sang destiné à rechercher une infection sanguine microbienne.

Hémolyse — Destruction des globules rouges.

Hypnozoïte — Forme hépatique dormante présente chez certaines espèces de Plasmodium.

Hypoglycémie — Baisse anormale de la glycémie.

Ictère — Coloration jaune de la peau et des muqueuses liée à une accumulation de bilirubine.

Infection cosmopolite — Infection pouvant être rencontrée dans de nombreuses régions du monde.

Infection tropicale — Infection fortement liée à certains contextes géographiques et écologiques tropicaux.

LAMP — Technique moléculaire d'amplification d'acides nucléiques, distincte de la PCR.

Létalité — Proportion de personnes atteintes d'une maladie qui en décèdent.

Mérozoïte — Forme parasitaire capable d'envahir de nouveaux globules rouges.

Moustiquaire imprégnée — Moustiquaire traitée avec un insecticide adapté pour réduire le risque de piqûres.

Paludisme — Maladie parasitaire provoquée par des protozoaires du genre Plasmodium.

Parasitémie — Présence et, selon la mesure, quantité de parasites dans le sang.

PCR — Technique d'amplification moléculaire permettant de rechercher du matériel génétique.

Plasmodium — Genre de protozoaires parasites responsables du paludisme.

Plasmodium falciparum — Espèce majeure associée à des formes sévères du paludisme.

Plasmodium ovale — Espèce pouvant persister sous forme hépatique dormante.

Plasmodium vivax — Espèce pouvant persister sous forme hépatique dormante.

Primo-invasion — Première phase clinique après la contamination et la multiplication du parasite.

Prophylaxie — Ensemble de mesures visant à empêcher une maladie ou à en réduire le risque.

Recrudescence — Réapparition d'une parasitémie liée à une persistance de parasites sanguins.

Rechute palustre — Nouvel épisode pouvant provenir de formes hépatiques dormantes pour certaines espèces.

Rosetting — Adhésion d'hématies non parasitées autour d'une hématie parasitée.

Séquestration — Rétention d'hématies parasitées dans les microvaisseaux des tissus.

Schizonte — Stade de multiplication du parasite donnant naissance à plusieurs formes filles.

Sporozoïte — Forme parasitaire inoculée à l'humain par le moustique infecté.

TDR — Test de diagnostic rapide, généralement fondé sur la détection d'antigènes.

Trophozoïte — Stade de développement et de nutrition du parasite.

Vecteur — Organisme qui transporte et transmet un agent infectieux entre hôtes.

VIH — Virus de l'immunodéficience humaine, à envisager selon les expositions et la clinique.